Station 1

Molly födde sitt första barn för 7 timmar sedan. Det uppkom bristningar nära urinröret och det är svullet i området. Molly förmår inte tömma urinblåsan. Du planerar att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- **Instruera undersköterskan om materialbehov samt övriga rutiner för ren kateterisering av urinblåsan (KAD).**

- **Genomföra lämplig åtgärd med assistans av undersköterskan.**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Instruerar undersköterskan om att KAD ska sättas och att us ska tvätta rent underlivet med tvål och vatten (eller Descutan) alt. utföra detta själv på ett adekvat sätt.	1	0.5	0
Ser till att KAD, kuffspruta och KAD-påse finns tillgängligt före eller under proceduren.	1	0.5	0
Ber undersköterskan om hjälp med att hålla isär blygdläpparna alt. gör detta själv på ett adekvat sätt.	1	0.5	0
Applicerar bedövningsgel i urinröret.	1	0.5	0
För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin.	1	0.5	0
Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten.	1	0.5	0
Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern.	1	0.5	0
Sätter på kateterpåse adekvat.	1	0.5	0
Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Clear Fail	Borderline	Clear Pass	Good Pass	Excellent
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 2

Du kommer att få se en film på svenska med konsultation mellan en psykiater och en patient. Patienten är en 42 årig gift man med två barn som är tre respektive fem år gamla. Han arbetar som bilmekaniker och har inga kända sjukdomar.

- **Lyssna och observera noggrant** (drygt 2.5 minuter).
- **Du kommer att få några få statusfynd skriftligt innan filmen startas.**

Uppgifter:

1) När Du sett filmen skall du föreslå mest **sannolika diagnos.**

2) Därefter ge korrekta förslag på **akut handläggning och behandling** av patienten baserat på din bedömning. Fokus ligger på att kunna handlägga och behandla.

3) Därefter ge **tre korrekta alternativ till långsiktig läkemedelsbehandling** för att minska risken för återfall.

4) Du är också skyldig att göra **ytterligare en åtgärd**, vilken?

OBS: Viktigast är att du **snabbt kommer fram till diagnos** och därifrån **handlägger korrekt**. När 1 minut återstår kommer examinatorn att påtala detta.

Bedömningen beror på:

-hur nära din föreslagna diagnos stämmer
-hur du kan värdera anamnes och status
-Handläggning/behandling

Diagnos	1p	0p
Hotande/aktuellt Delirium Tremens, alkoholabstinens 1p Andra diagnoser 0p	1	0
Feedback..		

Status	1p	0p
Högt blodtryck/puls, tremorös, rödbrusig, orolig/agiterad, hallucinatoriskt beteende 1p	1	0
Feedback..		

Handläggning/behandling	3p	2p	1p	0p
Alkoholabstinens/hotande DT: Ge bensodiazepiner (eller hemineurin) 1p, dosering styrs av abstinenssymptom 1p	- NA -	2	1	0
Skydd mot W-K-s: Ge tiamin i.m. 1p, ska ges innan glukos/mat 1p	- NA -	2	1	0
Långsiktig behandling: Disulfiram (Antabus), Naltrexon (Revia), Akamprosat (Campral) 3p	3	2	1	0
Annan åtgärd: Orosanmälan om att barn far illa ska göras till socialtjänsten 2p **(kan vara ok om man påminner om att det finns små barn)**	- NA -	- NA -	1	0
Feedback..				

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. Bedömning av genomförandet (magkänsla snarare än utifrån poängsättning ovan) Excellent – Rätt diagnos, rätt status/anamnes, rätt behandling, soc anmälan Good pass – Rätt diagnos, fångar de flesta statusfynden, rätt behandling, soc anmälan Clear pass –Hyfsat rätt riagnos, kan hyfsat behandling, förstår att det är allvarligt, ger benso och ”b-vitamin” Borderline –Generellt osäker, missar på behandling, kommer på B-vitamin först efter påminnelse, soc anmälan först efter påminnelse Clear fail- Missar diagnos, förstår ej att det är allvarligt, kan ej ordinera benso, missar tiamin, missar soc anmälan osv					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 3

Som neurologjour får du ett strokelarm om en 70-årig kvinna som hittats medvetandesänkt på badrumsgolvet. Patienten är stabil respiratoriskt och cirkulatoriskt när du träffar henne på akutrummet så du fokuserar på att undersöka patienten neurologiskt och utifrån dina undersökningsfynd bestämma fortsatt handläggning.

Du ska alltså undersöka patienten neurologiskt. Kontrollera inte A, B och C. Du ska därefter föreslå adekvat handläggning och behandling.

Berätta hela tiden för bedömaren vad du gör!

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Nervstatus	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tilltalar patienten, sedan berör, sedan höjer rösten/ruskar patienten	1	0
Perifer smärtstimulering på nagelbädd/nagelband i alla fyra extremiteter	1	0
Central smärtstimulering – över sternum, nervus supraorbitalis eller käkvinklar	1	0
Pupillreaktion bilateralt	1	0
Kontroll av nackstelhet	0.5	0
Tittar på ögonens ställning genom att öppna båda ögonen samtidigt	1	0
Kontrollerar babinskis tecken	0.5	0
Feedback..		

Bedömning	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Korrekt RLS (3)	1	- NA -	0
Beställer undersökningar, DT hjärna ska ingå för poäng	1	- NA -	0
Välja rätt DT-bild för patienten	1	- NA -	0
DT-bilden. Ange: infarkt (Ischemisk stroke) 0.5p intracerebral blödning 0.5p	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

En 63-årig bussförare kommer på planerat återbesök 3 månader efter en hjärninfarkt på vårdcentralen. Vid insjuknandet fanns svaghet i vänster arm och blev utskriven efter två dagar. Känner sig nu återställd.

Sekundärpreventiva insatser är adekvata. Fokus ligger på körkortet. Du har redan genomfört MMSE-SR som visar 29 av 30 poäng (finns i rummet)

Dina uppgifter

- **Utföra ett klocktest**
- **Komplettera vid behov anamnesen**

  sen
- **Informera patienten om fortsatt handläggning**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Studenten tolkar fynden och förklarar för patienten	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande: Studenten sammanväger resultat från MMSE-SR med klocktestet och förklarar för patienten vad detta innebär. Delvis tillfredsställande: Studenten förklarar delar av fynden alternativt bristfällig tolkning eller förklaring. Ej tillfredsställande: Fynden förklaras inte för patienten, eller undersökningen inte adekvat utförd så att fynden kan tolkas adekvat.	2	1	0
Feedback..			

Studenten kompletterar anamnes	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande: Lämplig och riktade frågor kring minnet, tar även upp bilkörning och vapen. Delvis tillfredsställande: Enstaka frågor eller överdrivet många och delvis irrelevanta frågor. Tar upp bilkörning eller vapen. Ej tillfredsställande: Inga frågor.	2	1	0
Feedback..			

Studenten kompletterar övrig anamnes	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande: Lämplig och riktade frågor vilket ger fyllig anamnes. Delvis tillfredsställande: Enstaka frågor eller överdrivet många och delvis irrelevanta frågor. Ej tillfredsställande: Inga frågor.	2	1	0
Feedback..			

Föreslår adekvat fortsatt utredning	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande: Lämplig och riktade utredningsförslag (remiss för utredning av körkortslämplighet vid sjukhus, trafikmedicinsk enhet eller röntgen av hjärnan med förklaring varför). Delvis tillfredsställande: Delvis relevanta utrednings/handläggningsförslag, (t ex ”blodprover”). Ej tillfredsställande: Inga utredningsförslag.	2	1	0
Feedback..			

Föreslår relevant handläggning av konsekvenser	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande: Lämplig och relevanta åtgärder - förbjuder körning OCH erbjuder fortsatt sjukskrivning (vapenförbud och erbjudande om färdjänst också relevant). Delvis tillfredsställande: Enstaka relevant åtgärd (förbjuder köra ELLER sjukskriver) eller delvis irrelevanta åtgärder. Ej tillfredsställande: Inga åtgärder.	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. **Clear Fail om studenten tillåter körande av bil och buss då det drabbar tredje person. I övrigt som tidigare mycket bristande kunskaper i kombination med en oprofessionell attityd till patienten.**					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 6

Du är jour. En ambulans kommer in en med en 15-årig man, som enligt vittne, för ca 15 minuter sedan fallit ihop och krampade i en restaurang. Anfallet hävdes spontant efter några minuter. Patienten har varit medvetslös ytterligare 5 minuter. Vid inkomst till akutrummet slö, reagerar på tilltal (RLS 2). Patienten lämnas snabbt på akutrummet då ambulansen direkt åker på ett annat uppdrag. Precis när du kommer in börjar patienten krampa igen.

Du ska akut bedöma och handlägga situationen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
A: Säkerställer fria luftvägar (käk lyft/svalgtub)	1	0.5	0
B: Kontrollerar andning (tittar, känner, lyssnar)	1	0.5	0
Ger syrgas	1	- NA -	0
C: Kopplar pulsoximetern (0.5p), kapillär återfyllnadstid (0.5p)	1	0.5	0
Sätter in en infart (eller frågar om en finns)	1	0.5	0
Ordinerar midazolam 7,5 mg i.v. (alt. diazepam 10 mg i.v., lorazepam 4mg i.v.) inom 2 minuter (0.5 - 1p)* *0.5 poäng om > 2 minuter eller studenten kan inte namn på något läkemedel *dra inte av poäng om studenten inte kan exakt dos	1	0.5	0
Ordinerar b-glukos	1	- NA -	0
Tillkallar IVA-jouren (0.5p/delvis tillfredsställande om den tillkallas först vid ett förslag)	1	0.5	0
Rapporterar till IVA-jouren enligt SBAR	1	0.5	0
Kommunicerar tydligt med sjuksköterska	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Du är läkare på BVC. En förälder kommer med sin baby Stina 3 månader. Just nu täta kontroller då barnet har mycket bristfällig viktuppgång. Ditt team på BVC fick veta vid föregående besök att barnets andra vårdnadshavare återfallit i missbruk. Enligt rutin har ni tagit beslut om att anmäla misstanke om barn som far illa, så kallad orosanmälan till socialtjänsten.

Informera den närvarande föräldern att anmälan skickas.
Ta anamnes och göra en plan framåt för er vårdkontakt.

OBS ingen undersökning av barnet ingår vid dagens besök, fokusera på samtalet.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Förmåga att lyssna in den anhöriges frustration och missnöje	2 p	1.5 p	1 p	0.5 p	0 p
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. **Tillfredsställande (1,5-2p):** Förmår att lyssna in och ge plats åt den frustration och det missnöje vårdnadshavaren har på ett patientcentrerat sätt. **Delvis tillfredsställande (0,5-1p):** Uppvisar basala färdighet till att lyssna in ge plats åt den frustration och det missnöje vårdnadshavaren har på ett patientcentrerat sätt. **Ej tillfredsställande (0p):** Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för vårdnadshavarens upplevelse.	2	1.5	1	0.5	0
Feedback..					

Förmåga till allianskapande i utmanande situation	2 p	1.5 p	1 p	0.5 p	0 p
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. **Tillfredsställande (1,5-2p):** Förmår på ett fullgott sätt återkoppla den frustration den anhörige uttryckt för situationen. Går ej i försvar. Kan bemöta sakligt. **Delvis tillfredsställande (0,5-1p):** Uppvisar basala färdigheter att återkoppla frustrationen vårdnadshavaren. **Ej tillfredsställande (0p):** Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för den anhöriges upplevelse.	2	1.5	1	0.5	0
Feedback..					

Frågar upp om oro och farhågor kring den rådande situationen	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande (1p): Förmår på ett fullgott sätt fråga upp om vårdnadshavarens oro och frustration kring den uppkomna situationen och bemöta denna på ett adekvat sätt. **Delvis tillfredsställande (0,5p):** Uppvisar basala färdighet till att ställa relevanta frågor och möta dessa. **Ej tillfredsställande (0p):** Förmår ej genomföra uppgiften på ett tillfredställande sätt.	1	0.5	0
Feedback..			

Frågar upp kring barnets och den närvarande förälderns mående och utsatthet	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tillfredsställande (1p): Frågar upp om eventuell utsatthet för våld hos barn och förälder. **Delvis tillfredsställande (0,5p):** Frågar upp om mående hos föräldern. **Ej tillfredsställande (0p):** Frågar ej upp om detta.	1	0.5	0
Feedback..			

Frågar upp kring vilket stöd som föräldern vill ha/kan tänka sig från BVC	2 p	1.5 p	1 p	0.5 p	0 p
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. **Tillfredsställande (1,5-2p):** Kan på ett patientcentrerat, lyhört sätt närma sig den anhörige i vilket stöd den kan behöva och vilja ha från BVC. Kan förklara varför behovet finns men utan att köra över eller moralisera för föräldern. **Delvis tillfredsställande (0,5-1p):** Kan på ett delvis patientcentrerat och lyhört sätt närma sig den anhörige i vilket stöd den kan behöva och vilja ha från BVC. **Ej tillfredsställande (0p):** Förmår ej genomföra uppgiften frågar inte eller är inte lyhördhet för vårdnadshavaren.	2	1.5	1	0.5	0
Feedback..					

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar om förälderns sociala nätverk för övrigt, tex föräldrar, vänner osv.	1	0
Gör en planering med föräldern kring uppföljning.	1	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 9

Du kommer att få se en film på svenska med ett kort utklipp ur en konsultation mellan en psykiater och en patient.

- **Lyssna och observera noggrant** (drygt 2.5 minuter).

Uppgifter:

Hur värderar du suicidrisken?

Vad i anamnes och status indikerar en förhöjd suicidrisk?

Vad i anamnes och status kan anses vara skyddande faktorer?

Vad är en lämplig vårdnivå?

Hur påverkar vårdnivån suicidrisken?

Vilka är de viktigaste delarna i dokumentationen av suicidrisken?

Bedömningen beror på:
-Hur du kan värdera anamnes och status
-Handläggningen
-Dokumentationen

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	3p	2p	1p	0p
Suicidriskbedömning: Hög risk 1p	- NA -	- NA -	1	0
Status och anamnesfynd talande för förhöjd suicidrisk: Depression, tidigare suicidförsök, suicidplaner, förberedelse för suicid, kronisk värk. 1p per anledning men max 2p	- NA -	2	1	0
Skyddande faktorer i status och anamnes: Har några bärande kontakter, är avledbar, hjälpsökande (söker själv hjälp istället för att agera på s-tankar), har ändå några framtidsplaner. (kvinna), ålder 1p per anledning men max 2 p (antagonister kan inte ge poäng i båda delfrågorna)	- NA -	2	1	0
Vad är en lämplig vårdnivå: Inläggning 1p	- NA -	- NA -	1	0
Hur påverkar vårdnivån suicidrisken: Sänkt risk 1p	- NA -	- NA -	1	0
Centrala aspekter att journalföra vid suicidriskbedömningen: Hög risk dokumenterat i journalen (1p), grundat på patientens inställning till livet, riskfaktorer och patientens status. (1p) Dokumentation suicidrisk efter insatta åtgärder. (1p) 1p per delmoment max 3p	3	2	1	0

Feedback..

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. Helhetsbedömning av genomförandet (magkänsla snarare än utifrån poängsättning ovan) Excellent – Rätt bedömning, rätt status/anamnes, rätt vårdnivå och dokumentation Good pass – Rätt bedömning, fångar de flesta status/anamnes fynden, rätt vårdnivå, relativt god dokumentation. Clear pass –Hyfsat rätt bedömning men osäker på de flesta delmomenten Borderline –Generellt osäker på allvaret i situationen, uppfattar begränsat med risk och skyddsfaktorer, olämplig handläggning, tveksam dokumentation. Clear fail- Förstår ej att det är allvarligt, kan ej se riskfaktorerna					

Feedback..

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 10

Du arbetar som underläkare på en kirurgavdelning och ska ronda en patient som har en trachealkanyl sedan flera veckor. Patienten har varit vårdad på IVA med respiratorisk insufficiens efter hemikolektomi och sepsis. Patienten är överviktig, ödematös och har en kuffad kanyl.

Du ska:

- **Genomföra gårond**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
1. Studenten tar bort luftfuktaren och innerkanylen	2	1	0
2. Studenten larmar	1	- NA -	0
3. Studenten suger rent och sprayar/droppar koksalt i trachealkanylen.	2	1	0
4. Studenten kuffar ur och tar ut hela kanylen.	2	1	0
5. Studenten sätter in en ny kanyl/håller luftvägen öppen med ett nässpekulum.	2	1	0
6. Studenten kan ange en rimlig förklaring till varför det kan vara stopp i kanylen. (dislocerad/framför trachea, granulationsvävnad i spetsen, koagel i trachea vid kanylen).	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. Om studenten inte kommer fram till att man bör ta ut hela kanylen för att lösa problemet så är detta en ”clear fail”. Om studenten direkt tar ut hela kanylen utan att först ta ut innerkanylen är också en grund för "clear fail".					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 11

Du vikarierar som underläkare på en röntgenavdelning. Du ska granska och bedöma två patienters undersökningar. Vid varje patientfall finns diagnosförslag. Granska i två minuter. Välj den/de diagnos(er) som du anser är korrekt och ange den/dem muntligen till figuranten som är en läkarstudent på termin 8. Därefter kommer läkarstudenten be dig visa fynden och ställa några kompletterande frågor. Du behöver inte logga in.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Fall 1, moment 1	**2**	**1**	**0**
Diagnosalternativ (max 2p) Korrekt diagnos, Posttraumatisk inflammation =2p. Kvarvarande viabelt lymfom = 1p. Övriga alternativ=0p.	2	1	0
Fall 1, moment 2	**1**	**0.5**	**0**
Demonstration. Peka ut fynd/fynden (max 1 p) Ökad metabolism i leden och omgivande mjukdelar. Hill Sachs impression/fraktur i caput humeri, ökad kontrastladdning och vätska kring leden. Anger minst 2 av fynden ovan = 1p. Anger minst 1 av fynden ovan= 0,5p	1	0.5	0
Fall 1, moment 3	**1**		**0**
Demonstration. Ange korrekt lokalisation (max 1p) Anger höger axelled = 1p. Anger vänster axelled = 0p.	1		0
Fall 1, moment 4	**1**	**0.5**	**0**
Förklara/motivera diagnosen (max 1p) Anger att metabolism + karakteristisk impressionsfraktur + periartikulär kontrastladdning och vätska + anamnes talar för status post luxation =1p. Anger att subfebrilitet + metabolism + ev patologisk fraktur skulle kunna tala för kvarvarande lymfom = 0,5p. Övriga alternativ=0p. Frakturen + avsaknad av hög feber talar emot akut septisk artrit. Inte typiskt utseende för caputnekros.	1	0.5	0
Fall 2, moment 1	**2**	**1**	**0**
Diagnosalternativ (max 2p) Båda diagnoserna/fynden korrekta KOL/Emfysem samt Infiltrat=2 p En diagnos/ett fynd korrekt =1p. Övriga alternativ =0p.	2	1	0
Fall 2, moment 2	**1**	**0.5**	**0**
Förklara/motivera diagnos 1 (KOL) (max 1p) Motiverar diagnos 1: Visar tecken på emfysem (tunnformig bröstkorg, nedpressade diafragmavalv, ökad retrosternal lufthalt) Anger minst 2 av fynden ovan = 1p. Anger minst 1 av fynden ovan= 0,5p	1	0.5	0
Fall 2, moment 3	**1**	**0.5**	**0**
Demonstration. Visar på diagnos 2 (infiltrat) med dess korrekta lokalisation (max 1p) Visar infiltratet, anger rätt sida (vänster) = 0,5p och rätt lob (underloben) = 0,5p.	1	0.5	0
Fall 2, moment 4	**0.5**		**0**
Demonstration. Peka ut fynd 3 (max 0,5p) Visar vänstersidig pleuravätska = 0,5p.	0.5		0
Fall 2, moment 5	**0.5**		**0**
Förklarar undersökningsteknik (max 0,5p) Motiverar fynd 3/undersökningsteknik: Förklarar hur vätskebilder är exponerade (i sidoläge/liggande på sida med horisontell strålriktning). Helt korrekt förklaring erfordras för 0,5p. Alla andra förklaringar = 0p.	0.5		0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. Clear fail: Uppträder otrevligt mot figuranten. Om en student uppenbart saknar de färdigheter som testas i stationen men trots detta pekar tydligt på helt fel strukturer och låter säker och övertygande. (Bedöms vara ett beteende som kan innebära en säkerhetsrisk om hen beter sig på det sättet utan självinsikt i en klinisk situation.)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 12

Emma, 23 år, söker på grund av låga buksmärtor av huggande, kortvarig karaktär sedan några månader. Graviditetstestet är negativt. Emma är tidigare gynekologiskt frisk. Hon befarar att hennes smärtor har gynekologisk orsak.

Du ska:

- **Genomföra en korrekt gynekologisk undersökning och beskriva dina undersökningsfynd avseende utseendet av vulva, vagina och portio/cervix.**

- **Göra en storleksbedömning av livmodern.**

- **Sammanfatta patientfallet enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).**

Undersökningen utförs på en gyn-docka. Du kommer att bedömas för ditt genomförande av en gynekologisk undersökning inklusive hygieniska aspekter, de undersökningsfynd och den sammanfattning som du rapporterar till bedömaren.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten ställer in ljuskällan och höjd på gynstol korrekt.	1	0.5	0
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt.	2	1	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio/cervix.	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt.	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är normalstor.	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik.	3	1.5	0
Studenten sammanfattar patientfallet för bedömaren enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 14

Stationen handlar om att undersöka pupillreflexerna.

En 58-årig man söker akut på vårdcentralen p.g.a. att höger pupill är större än vänster. Han upptäckte detta idag på morgonen. Vid din undersökning finner du fullgod synskärpa på båda ögonen (1,0). I stationen ska du undersöka direkt och indirekt pupillreflex på båda ögonen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Korrekt belysning	1	- NA -	0
Korrekt ljuskälla	1	- NA -	0
Korrekt undersökningsavstånd	1	- NA -	0
Belyser ögonen på korrekt sätt	1	- NA -	0
Beskriver korrekt hur hen kontrollerar direkt och indirekt pupullreflex	2	1	0
Beskriver avvikelserna korrekt	2	1	0
Svarar rätt på följdfrågan	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 15

Du befinner dig på en akutmottagning och har två urologiska patienter med 2 typer av **akut avflödeshinder**. Du behöver både snabbt och korrekt kunna bestämma dig för individuella kateterval (KAD) för respektive patient: anamnesen är A.O. För första patienten finns dessutom labdata. Du ska kunna förklara momenten för patienten samt även förklara om felcuffningsriskerna.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Patient 1	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Presentera sig för patient 1 och ta en anamnes som leder till rätt val av KAD	2	1	0
Motiverat val av korrekt kateter (trevägs hematuri-KAD), samt förklara för patienten hur KAD-sättningen ska gå till	2	1	0
Inför katetersättningen (vilken inte utförs) ta fram rätt tilläggsmaterial och motivera varför	1	- NA -	0
Handspola primärt efter imaginär sättning av KADn samt därefter koppla tilläggsmaterialet rätt	1	- NA -	0
Feedback..			

Patient 2	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Presentera sig för patient 2 och ta en anamnes som leder till rätt val av KAD	2	1	0
Motiverat val av korrekt kateter (Foley-KAD med Tiemann-tip), samt förklara för patienten hur KAD-sättningen ska gå till (katatersättningen utförs inte)	1	- NA -	0
Beskriva riskerna med fel-cuffning, beskriva principerna för att avgöra korrekt KAD-läge i urinblåsan före cuffning samt genomföra en beständig cuffning	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 16

Du kommer att möta ett fall. Detta fall är en drunkningsolycka hos en 10-månaders gammal pojke.

Scenario:
Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10–månaders gammal pojke, Vincent. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och pojken sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Vincent ligger ner i poolen och hostar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Kontrollera medvetande och om det andas	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning. [hostar ineffektivt och har inspirisk stridor]	1	0.5	0
Feedback..			

Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor barnet och att barnet är vid medvetande (om än tagen).	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt. Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr. Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt. Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum. Tittar i munnen och plocka ut [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter]. *Instruera studenten att hen inte hittar något.* Studenten gör om proceduren.	1	0.5	0
Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet. Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112. Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; ”vad ska jag göra?”. Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn.	1	0.5	0
Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas.	0.5	- NA -	0
När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar [Kontrollera att bröstkorgen häver sig]	1	- NA -	0
Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig) [Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst]	1	- NA -	0
Feedback..			

Studenten påbörjar hjärtkompressioner	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Rätt antal och frekvens [kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s]	1	0.5	0
Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar [trycker med 2 fingrar/två tummar i/på bröstbenets nedre halva, inblåsningar där bröstkorgen häver sig] Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva.	1	0.5	0
Feedback..			

	Tillfredsställande	**Ej tillfredsställande**
Gör ovanstående i rätt ordning [ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera].	0.5	0
Feedback..		

Instruera nu att barnet kräks	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten lägger barnet i framstupa/stabilt sido-läge och därefter kontrollerar andningen, lyssnar, känner och tittar.	1	0.5	0
Feedback..			

Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska ge korrekt rapport	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
"Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning".	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10